

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0242

Paginas del documento: 5

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

cientes no estudo, a maioria do sexo feminino (67,5%), e a média de idade foi 58,47 controle da PA na amostra foi de 42,3%. Cerca de 71 pacientes da amostra total da MAPA anormal. As medidas da MAPA, sejam elas totais e/ou na vigília, foram significativamente maiores no grupo em que foi aplicado o folder. Todas com $p < 0,05$. **Conclusão:** O uso do folder favoreceu maior número de leituras válidas e assim permitiu que não houvesse nenhuma repetição do exame, com potencial para ser utilizado na prática assistencial.

Palavras-chaves: Hipertensão, pressão arterial, MAPA; material educativo; folder.

INTRODUÇÃO

A MAPA é um método diagnóstico que permite o registro indireto e intermitente da PA durante 24 horas. Além de ser importante para a exclusão do efeito do avental branco (HAB) e da hipertensão mascarada (HM), também possui papel na determinação precisa do diagnóstico da HA, como também na avaliação da eficácia do tratamento anti-hipertensivo (1,2).

Para se obter uma boa qualidade técnica e, consequentemente, resultados mais precisos através da MAPA, é fundamental que sejam fornecidas orientações adequadas e claras aos pacientes. Os materiais educativos nos serviços de saúde objetivam reforçar as orientações transmitidas oralmente, além de permitir ao paciente e à sua família a realização de uma leitura posterior, servindo como guia em casos de dúvidas. Existem vários formatos de materiais educativos, dentre eles, folder (1,3).

FIGURA 1: Folder Educativo para o exame da MAPA

ORIENTAÇÕES PARA O EXAME DA MAPA

- 1** Não falar no momento em que o aparelho estiver medindo a pressão;
- 2** Deverá manter as atividades habituais durante a realização do exame. É proibido praticar exercícios físicos durante o período de realização do exame;
- 3** Não tomar banho durante a realização do exame;
- 4** Não desinsuflar abraçadeira manualmente;
- 5** Não dormir por cima da braçadeira, nem dobrar o tubo;
- 6** Anotar a ocorrência e horários de situações estressantes.
- 7** Não esquecer de preencher o "DIÁRIO DO PACIENTE", anotar os horários das atividades principais do dia. Ex: Hora de dormir, acordar, descansar, caminhar, principais refeições, incluindo o consumo de álcool, cigarros, café e horário em transporte;
- 8** Anotar o horário que dormiu e acordou, e registrar a qualidade do sono (bom, regular ou ruim);
- 9** Anotar o nome, dose e horário de uso dos medicamentos e possíveis sintomas (tontura, dor de cabeça, falta de ar, etc.);
- 10** Anotar a ocorrência e horários de situações estressantes.

The folder contains 9 numbered illustrations of a patient in a green shirt and black pants, demonstrating correct and incorrect behaviors during the MAPA exam:

- 1:** Standing correctly with arms at sides. Text: "Se estiver em pé durante as medições, manter-se parado e sem falar, postura ereta, braços esticados e palma da mão aberta."
- 2:** Sitting correctly in a chair. Text: "Se estiver sentado durante as medições, manter-se parado e sem falar, as costas e o ombro devem estar apoiados, pernas descoladas, pés apoiados no chão, e a palma da mão aberta."
- 3:** Holding a clipboard. Text: "Não esquecer de preencher o 'DIÁRIO DO PACIENTE', anotar: Os horários das atividades principais do dia, também o nome, a dose e horário de tomada dos medicamentos."
- 4:** Holding the device. Text: "Ao retirar o aparelho da cintura, manter sempre na posição horizontal, com o visor virado para a esquerda (lado da braçadeira)."
- 5:** Lying down. Text: "Ao se deitar, manter o aparelho na altura da cabeça. Não dobrar o tubo da braçadeira. Não se deitar sobre o braço que está com a braçadeira instalada."
- 6:** Incorrectly bending the tube (marked with a red X). Text: "ATENÇÃO, PROIBIDO dobrar o tubo da braçadeira em qualquer momento durante o manuseio do aparelho."
- 7:** Holding a medication bottle. Text: "Nome, dose e horário dos medicamentos utilizados."
- 8:** Exercising. Text: "Não praticar exercícios físicos durante o período de realização do exame."
- 9:** Adjusting the cuff. Text: "Deverá registrar a abraçadeira ao longo do dia, para permanecer sempre na mesma posição que foi colocado durante a instalação."

Zeferino et al.

de material prático e de fácil com-
as orientações verbais prestadas
ninstalação (4,5).

Geralmente são fornecidas, para realização da MAPA, as instruções em forma em textos, entretanto é sabido que parcela da população possui baixa escolaridade (6) o que aumenta a dificuldade em compreender informações escritas. Portanto, o objetivo do presente estudo foi o desenvolvimento de um folder educativo com uso de imagens e informações escritas para facilitar a compreensão dos pacientes e assim favorecer maior número de leituras válidas, reduzindo a necessidade de repetição do exame, o que aumenta custos para o sistema de saúde além de configurar um transtorno para o paciente.

Segundo as 6ª Diretrizes de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial e 4ª Diretrizes de Monitorização Residencial de Pressão Arterial, para o exame ser considerado válido para interpretação adequada, deverá apresentar pelo menos 16 medidas válidas no período de vigília e 8 durante o período de sono. Exames com 20% ou mais de exclusões de medidas são, provavelmente, resultantes de problemas técnicos do aparelho ou de falta de colaboração do paciente (1). Neste particular, especialmente, a melhor orientação a partir de meios visuais pode ser um fator diferencial para o sucesso do procedimento.

Estudos científicos demonstram que imagens são melhores para gravar e para gerar a compreensão e o entendimento das pessoas (5,7). Diante do exposto, a tecnologia educativa foi elaborada com o intuito de contribuir na compreensão do paciente e, desse modo, obter maior número leituras válidas.

MÉTODOS

Estudo de intervenção aberto, realizado nos serviços de cardiologia de hospitais, público e privado, em Maceió – AL, no período de novembro de 2021 a junho de 2022. Foram incluídos no estudo pacientes maiores de 18 anos, com diagnóstico de HA e sob tratamento medicamentoso. Os pacientes foram avaliados quanto ao tratamento farmacológico, pressão arterial (PA).

orientação padrão um folder informativo com imagens que transmitem as principais mensagens para realizar uma boa execução do exame, as instruções escritas foram alocadas próximas às imagens que as relacionava, com o intuito de facilitar a compreensão do conteúdo e tornar o material mais atrativo, de acordo com a (Figura 1).

Para as análises dos períodos de 24 horas, vigília e sono foram adotadas as recomendações das 6ªs Diretrizes de MAPA e as 4ªs Diretrizes de Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA). Valores anormais de PA pela MAPA (mmHg) período 24 horas $\geq 130/80$, vigília $\geq 135/85$ e sono $\geq 120/70$.

O folder foi fornecido (grupo intervenção) no momento da instalação dos aparelhos de MAPA.

A pesquisa ocorreu em três etapas:

1. Após a consulta com o cardiologista e elegibilidade para a pesquisa, o paciente era encaminhado para entrevista e posterior instalação da MAPA. Nesse momento, a pesquisa era apresentada e em caso de aceite, era solicitada a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).
2. Nesta etapa o monitor foi programado (períodos de vigília e sono), seguindo as recomendações das 6ª Diretrizes de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial e das 4ª Diretrizes de Monitorização Residencial da Pressão Arterial. Após a instalação do equipamento, foi comparada a medida obtida pelo monitor de MAPA com a medida obtida pelo aparelho automático.
3. Foram repassadas as orientações aos pacientes do sistema público de saúde e feita a entrega do folder educativo, criado justamente para contribuir com a compreensão dos pacientes na realização do exame. Para tal, foram seguidos todos os protocolos de instalação e instruções ao paciente preconizados nas 6ª Diretriz de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial e nas 4ª Diretrizes de Monitorização Residencial da Pressão Arterial.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

As análises consistiram em teste de qui-quadrado

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas (decisão nº: 47130221.3.0000.5013), e o estudo seguiu os princípios da Declaração de Helsinque. As imagens presentes no folder educativo foram obtidas mediante Termo de Autorização de Uso de Imagem, assinado pela paciente modelo.

Dos 123 pacientes incluídos no estudo (61 no grupo de intervenção (folder) e 61 no grupo controle), a idade média de idade dos pacientes foi $58,47 \pm 11,8$ anos, 67,5% eram do sexo feminino e 58,5% eram casados ou viviam com parceiro. As características dos grupos são apresentadas na (tabela 1).

Diferenças nas médias válidas do resultado da MAPA foram observadas entre os grupos que foram estatisticamente significantes no grupo intervenção (folder) (Tabela 2).

TABELA 1: Características sociodemográficas e número de medicamentos em uso entre os Grupos de pacientes, Maceió, 2023.

Característica	Grupo Intervenção (n = 62)	Grupo Controle (n = 61)	p
Sexo, N° (%)			
Masculino	19 (47,5%)	21 (52,5%)	0,654 ^a
Feminino	43 (51,8%)	40 (48,2%)	
Idade, média (DP)	56,18 (11,48)	60,67 (12,05)	0,026 ^b
N° de medicamentos prescritos, média (DP)	2,0 (1,0)	1,6 (0,7)	0,045 ^b
Escolaridade (anos de estudo)	10,3 (4,2)	11,9 (4,0)	0,027 ^b

a.Qui-quadrado; b.Teste de T para amostras independentes

TABELA 2: Médias válidas do resultado da MAPA dos pacientes com HA, 2023.

Número de Medidas Válidas			
	Grupo intervenção (Folder) Med (DP)	Grupo Controle (Orientações usuais) Med (DP)	p ^a
Mapa total	82,00 (4,9)	70,55 (8,8)	0,000
Porcentagem de Medidas Válidas	94,02 (6,83)	89,30 (10,62)	0,004
Medidas Válidas Vigília	62,06 (4,84)	48,43 (10,21)	0,000
Medidas Válidas Sono	15,73 (1,13)	16,93 (3,16)	0,006
Total de Medidas Perdidas	4,2 (5,6)	6,8 (9,4)	0,06

a.Teste de T para amostras independentes

da MAPA, sejam elas totais e/ou significativamente maiores no i aplicado o folder, no período de sono não se observou a mesma interferência o que reforça a ideia de que orientações que exploram recursos visuais podem colaborar para orientação do paciente.

Durante o período de monitorização, o comportamento da PA dos pacientes foi a seguinte: pacientes que utilizaram folder (normal = 24, anormal = 38); pacientes que não utilizaram folder (normal = 28, anormal = 33).

Este é o primeiro artigo que destaca a criação de folder educativo em pesquisa clínica para a realização do exame MAPA, e que evidencia que a tecnologia Os resultados demonstraram que o uso da tecnologia educativa contribui para uma melhor compreensão do paciente, por fornecer, além das orientações escritas, padrão convencional disponibilizado na maioria dos hospitais e clínicas, recursos visuais por meio de fotografias, neste contexto o uso das imagens facilitam o entendimento do paciente de maneira simples durante todo o período

terial, sem a necessidade de repetição do exame no paciente, isso nos leva a crer que a compreensão de como se comportar em relação ao uso do aparelho foi maior no grupo que recebeu o folder, não sendo necessário, a repetir o método em nenhum paciente nesse grupo.

Espera-se que este trabalho possa contribuir com outras pesquisas clínicas que trabalhem com aparelho de MAPA e que instituições de saúde possam utilizar a tecnologia educativa para facilitar a compreensão do paciente, obtenção de medidas validas e com isso evitar a repetição do procedimento, o que é sempre um transtorno para o paciente e para sua família.

FONTES DE FINANCIAMENTO

Não há fonte de financiamento.

DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram que não há conflitos de interesse em relação a este artigo.

REFERÊNCIAS

1. Brandão AA, Alessi A, Feitosa AM, Machado CA, Figueiredo CEP, Amodeo C, Rodrigues CIS, et al. 6ª Diretrizes de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial e 4ª Diretrizes de Monitorização Residencial da Pressão Arterial. Arq Bras Cardiol 2018; 110(5Supl.1):1-29

4. FREITAS, F.V.; REZENDE FILHO, L.A. Communication models and use of printed materials in healthcare education: a bibliographic survey. Interface - Comunic.,